

1. Introducción y relevancia clínica

El **acné vulgar** y la **rosácea** son enfermedades inflamatorias crónicas de la **unidad pilosebácea**, que afectan principalmente la piel del rostro y el tronco superior. Ambas comparten un impacto importante en la **autoestima**, **calidad de vida** y pueden dejar **secuelas cicatriciales** si no se tratan adecuadamente.

Acné vulgar

Es la **dermatosis más frecuente en adolescentes**, aunque puede persistir o debutar en la adultez. Su fisiopatología involucra la **hiperqueratinización folicular**, la **hipersecreción sebácea**, la proliferación de **Cutibacterium acnes** y la **inflamación**.

Rosácea

Es una **dermatosis inflamatoria crónica del rostro** caracterizada por **eritema persistente**, **telangiectasias**, **pápulas y pústulas**, sin comedones. Afecta principalmente a adultos de piel clara, con predominio en mujeres, aunque las formas severas (como el rinofima) son más comunes en hombres.

Relevancia clínica

- El acné y la rosácea son motivos frecuentes de consulta en atención primaria.
- Ambas requieren un **manejo integral** y prolongado.
- La elección del tratamiento depende de la severidad, tipo de lesión y edad del paciente.
- En EUNACOM, las preguntas suelen enfocarse en el **diagnóstico diferencial**, **clasificación** y **terapéutica racional** según guías MINSAL.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Acné vulgar

El acné se origina por una alteración multifactorial del **folículo pilosebáceo**.

Los cuatro mecanismos fundamentales son:

1. Hiperqueratinización del infundíbulo folicular

→ obstrucción del conducto sebáceo y formación de **comedón** (lesión primaria).

2. Hipersecreción sebácea

→ estimulada por andrógenos (testosterona y DHT).

3. Proliferación de *Cutibacterium acnes* (antes *Propionibacterium acnes*)

→ genera mediadores proinflamatorios (IL-1, IL-8, TNF- α).

4. Inflamación local

→ infiltrado de neutrófilos y linfocitos, que forma pápulas, pústulas y nódulos.

2.2. Rosácea

La fisiopatología exacta es compleja y multifactorial, con los siguientes factores:

- **Disregulación vascular** → vasodilatación crónica y eritema persistente.
- **Inflamación innata** → aumento de catelicidinas y péptidos antimicrobianos.
- **Microorganismos:** *Demodex folliculorum* (ácaro) puede contribuir al daño inflamatorio.
- **Factores ambientales:** calor, alcohol, estrés, luz solar y comidas picantes exacerban los síntomas.
- **Predisposición genética y de piel clara** (fototipos I y II).

2.3. Factores predisponentes

Acné vulgar	Rosácea
Pubertad y adolescencia	Edad adulta (30–50 años)

Aumento de andrógenos	Vasodilatación persistente
Cosméticos oclusivos	Alcohol, sol, calor
Corticoides tópicos o sistémicos	Corticoides tópicos prolongados
Estrés y dieta hiperglucídica	Comidas picantes, bebidas calientes

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Acné vulgar

Lesiones elementales

- Comedones (lesiones no inflamatorias):**
 - Abiertos (puntos negros):** por oxidación de la queratina y sebo.
 - Cerrados (puntos blancos):** obstrucción folicular sin salida del sebo.
- Lesiones inflamatorias:**
 - Pápulas:** elevaciones eritematosas sólidas.
 - Pústulas:** pápulas con contenido purulento.
 - Nódulos y quistes:** lesiones profundas, dolorosas, con riesgo de cicatriz.

Distribución típica

- Cara (zona T), pecho, espalda, hombros y parte superior de brazos.

Clasificación clínica (según severidad MINSAL 2023)

Grado	Tipo de lesiones predominantes	Manejo inicial

Leve	Comedones ± pápulas aisladas	Tópicos
Moderado	Pápulo-pustuloso	Tópicos + antibióticos
Severo	Nódulo-quístico o con cicatrices	Sistémicos (isotretinoína)

3.2. Rosácea

Lesiones y subtipos clínicos

1. Eritematotelangiectásica:

Eritema persistente centrofacial con telangiectasias visibles.

2. Papulopustulosa:

Pápulas y pústulas inflamatorias sin comedones.

3. Fimatosa (rinofima):

Engrosamiento y fibrosis del tejido nasal (más común en hombres).

4. Ocular:

Blefaritis, conjuntivitis, ojo seco y sensación de cuerpo extraño.

Zonas afectadas

- Mejillas, nariz, mentón y frente (zona centrofacial).

Síntomas subjetivos

- Ardor, calor o “flushing” (rubor súbito).
 - Sensibilidad cutánea aumentada.
 - Ojo rojo o lagrimeo (rosácea ocular).
-

3.3. Diagnóstico diferencial

Acné vulgar	Rosácea	Otras entidades
Presencia de comedones	Ausencia de comedones	Foliculitis, dermatitis perioral
Adolescentes	Adultos (30–50 años)	Lupus, dermatomiositis
Lesiones en cara y tronco	Lesiones centrofaciales	Seborrea, acné esteroideo
No hay flushing	Flushing frecuente	Eritema solar o medicamentoso

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Acné vulgar

Diagnóstico **clínico**, sin necesidad de exámenes complementarios en la mayoría de los casos.

Exámenes indicados si:

- Acné severo o de inicio súbito en adultos → descartar hiperandrogenismo.
 - Testosterona libre y total.
 - DHEA-S, LH/FSH.
 - Ecografía ovárica (SOP).
 - Sospecha de efectos secundarios medicamentosos (ej. corticoides, fármacos antiepilépticos).
-

4.2. Rosácea

También es un **diagnóstico clínico**.

Exámenes complementarios solo si hay diagnóstico dudoso o formas graves:

- **Biopsia cutánea:** infiltrado linfohistiocitario perivascular.
 - **Test de Demodex (raspado cutáneo):** útil si sospecha de infestación.
 - **Evaluación oftalmológica** si hay síntomas oculares.
-

4.3. Criterios diagnósticos de rosácea (BAD, 2024)

1. Eritema centrofacial persistente con pápulas/pústulas o telangiectasias.
2. Ausencia de comedones.
3. Sensación de ardor o rubor facial recurrente.
4. Exclusión de otras dermatosis (acné, lupus, dermatitis seborréica).

Diagnóstico confirmado: criterios 1 + 2, con apoyo clínico de 3 o 4.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Acné vulgar

A. Medidas generales

- Higiene facial con limpiadores suaves (no comedogénicos).
 - Evitar cosméticos oclusivos y manipulación de lesiones.
 - No usar alcohol, aceites o exfoliantes abrasivos.
 - Suspende anabólicos o corticoides si son causales.
-

B. Tratamiento farmacológico

Gravedad	Tratamiento	Comentarios
Leve	Tópicos: peróxido de benzoilo 2,5–5%, adapaleno, ácido azelaico	Evitar monoterapia antibiótica
Moderado	Tópicos + antibióticos orales (doxiciclina 100 mg/día o minociclina)	3–6 meses máx.
Severo o nódulo-quístico	Isotretinoína oral (0,5–1 mg/kg/día)	Controlar función hepática, lípidos y anticoncepción

Tratamiento tópico de primera línea

1. **Peróxido de benzoilo:** bactericida y comedolítico.
2. **Retinoides tópicos (adapaleno, tretinoína):** normalizan queratinización.
3. **Antibióticos tópicos (clindamicina o eritromicina):** solo combinados con peróxido.
4. **Ácido azelaico:** útil en piel sensible o con hiperpigmentación residual.

Tratamiento sistémico

- **Antibióticos orales:** tetraciclinas (doxiciclina, limeciclina).
 - **Isotretinoína oral:** el más eficaz; induce remisión prolongada.
 - **Efectos adversos:** xerosis, alteración hepática, teratogenicidad (anticoncepción estricta).
 - **Contraindicación:** embarazo (categoría X).
 - **Anticonceptivos orales combinados:** útiles en mujeres con acné hormonal.
 - **Espironolactona (50–100 mg/día):** opción antiandrogénica.
-

5.2. Rosácea

A. Medidas generales

- Evitar desencadenantes: alcohol, sol, comidas picantes, calor.
- Fotoprotección diaria (FPS $\geq$ 50).
- Higiene facial suave, sin jabones abrasivos.
- Suspender corticoides tópicos faciales (rosácea esteroidea).

B. Tratamiento farmacológico

Subtipo	Tratamiento de elección	Comentarios
Eritematotelangiectásica	Brimonidina tópica, láser vascular	Vasoconstricción y reducción del flushing
Papulopustulosa	Metronidazol o ácido azelaico tópico	Alternativa: ivermectina tópica
Moderada–severa	Doxiciclina 40–100 mg/día por 8–12 semanas	Efecto antiinflamatorio
Fimatosas	Isotretinoína oral a bajas dosis	Derivar a dermatología
Ocular	Lubricantes, higiene palpebral, doxiciclina	Control oftalmológico

Nota: La rosácea no se cura, pero el control prolongado reduce las recidivas.

6. Complicaciones y pronóstico

Enfermedad	Complicaciones	Pronóstico
Acné vulgar	Cicatrices atróficas o queloides, hiperpigmentación, impacto psicológico	Excelente con manejo precoz
Rosácea	Rinofima, queratitis o blefaritis crónica	Crónica, con remisiones y exacerbaciones

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Acné vulgar:** presencia de **comedones (abiertos o cerrados)** es diagnóstico.
 2. **Rosácea:** **ausencia de comedones + flushing facial + telangiectasias.**
 3. **Isotretinoína oral** es el único tratamiento que modifica el curso del acné severo.
 4. En **acné leve**, los **retinoides tópicos + peróxido de benzoilo** son base del manejo.
 5. En **rosácea**, el uso de **corticoides tópicos** empeora el cuadro.
 6. En EUNACOM, es típico que la pregunta compare **adolescente con comedones (acné)** vs **adulto con eritema y pápulas sin comedones (rosácea).**
-



Errores comunes

- Prescribir antibióticos tópicos en monoterapia (resistencia bacteriana).
- No realizar anticoncepción en mujeres con isotretinoína.
- Usar corticoides tópicos en rosácea (empeoran la enfermedad).

- No tratar adecuadamente las cicatrices postacné.
 - Confundir rosácea con lupus eritematoso (rash malar fotosensible).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **acné vulgar** es una enfermedad inflamatoria del folículo pilosebáceo causada por **hiperqueratinización, sebo, C. acnes e inflamación**.
2. Se clasifica según severidad en **leve, moderado y severo**, orientando su manejo terapéutico.
3. El **tratamiento de primera línea** combina **retinoide tópico + peróxido de benzoilo**, y **antibióticos o isotretinoína** según gravedad.
4. La **rosácea** es una enfermedad inflamatoria facial crónica con **eritema, telangiectasias y pápulo-pústulas sin comedones**.
5. El **metronidazol y ácido azelaico** son tratamientos tópicos efectivos; la **doxiciclina** se usa en casos moderados.
6. Evitar **corticoides tópicos** y **factores desencadenantes** es esencial en rosácea.
7. En EUNACOM, la clave está en **reconocer los comedones (acné)** y el **flushing centrofacial sin comedones (rosácea)**.